

سوال ۱ (ناحیه هیپ)

صورت سوال: شایعترین علت بورسیت تروکانتریک چیست؟

- الف) چاقی
- ب) اختلاف طول اندام های تحتانی
- ج) تروما
- د) استئوآرتریت هیپ

پاسخ تشریحی:

- ☒ گزینه ج (صحیح): بر اساس درسنامه، **تروما (ضربه)** به عنوان شایعترین علت بورسیت تروکانتریک معرفی شده است. زمین خوردن روی لگن یا ضربات مستقیم به این ناحیه می‌تواند به سرعت باعث التهاب بورس شود.
- ☐ گزینه الف، ب، د (غلط): چاقی، اختلاف طول اندام‌ها و استئوآرتریت هیپ همگی به عنوان علل و عوامل خطر بورسیت تروکانتریک در درسنامه ذکر شده‌اند. این عوامل با تغییر بیومکانیک راه رفتن و افزایش فشار بر روی بورس، زمینه را برای التهاب فراهم می‌کنند، اما درسنامه به طور مشخص "تروما" را به عنوان **شایعترین علت** بیان می‌کند.

نکات کلیدی درسنامه: بورسیت تروکانتریک (Trochanteric Bursitis)

- **آناتومی و مکانیزم:** بورسیت تروکانتریک، التهاب کیسه مایع (بورس) است که روی برجستگی استخوانی خارجی لگن به نام **تروکانتر بزرگ** قرار دارد. این بورس اصطکاک بین تاندون عضلات سیرینی (گلوئتال) و استخوان را کاهش می‌دهد. التهاب آن معمولاً ناشی از فشار یا اصطکاک مکرر است.
- **علل (اتیولوژی):**
 - **تروما:** زمین خوردن یا ضربه مستقیم به ناحیه خارجی لگن **شایعترین علت** است.
 - بیماری‌های مفصلی: استئوآرتریت مفصل هیپ یا ستون فقرات کمری.
 - عوامل بیومکانیکی: چاقی، اختلاف طول پاها و اسکولیوز (انحراف ستون فقرات).
 - بیماری‌های التهابی: مانند آرتریت روماتوئید.
- **علائم بالینی:**
 - **درد در ناحیه خارجی (لترال) هیپ** که علامت اصلی است.
 - درد با فعالیت‌هایی مانند **سوار یا پیاده شدن از ماشین**، بالا رفتن از پله و خوابیدن روی سمت مبتلا تشدید می‌شود.
 - **حساسیت نقطه‌ای (Point Tenderness)** در لمس مستقیم روی تروکانتر بزرگ.
 - درد ممکن است به سمت پایین و خارج ران تیر بکشد (درد شبه رادیکولار).
- **تشخیص (مانور بالینی):**

- تشخیص عمدتاً بالینی است. درد با حرکت ابداکشن (دور کردن پا از بدن) یا چرخش خارجی در برابر مقاومت ایجاد می‌شود. برای انجام تست، بیمار به پهلو می‌خوابد و سعی می‌کند پایی که بالاتر قرار دارد را در برابر مقاومت دست پزشک بالا ببرد.

• درمان:

- قرار دادن بالش کوچک زیر ناحیه مبتلا هنگام خواب.
- تزریق موضعی کورتیکواستروئید که معمولاً بسیار موثر است.
- انجام ورزش‌های کششی برای عضلات گلوئتال.
- جراحی (برداشتن بورس) به ندرت لازم می‌شود.

سوال ۲ (ناحیه هیپ)

صورت سوال: کدامیک از علائم بورسیت ایلئوپسواس نمی باشد؟

- الف) Cruralgia (کرورالژیا)
- ب) سیاتالژی
- ج) تورم اندام تحتانی
- د) درد در فلکسیون هیپ در برابر مقاومت

پاسخ تشریحی:

- ☒ گزینه ب (صحیح): سیاتالژی (Sciatalgia) به دردی گفته می‌شود که در مسیر عصب سیاتیک (پشت ران و ساق پا) انتشار می‌یابد. بورسیت ایلئوپسواس در جلوی مفصل هیپ رخ می‌دهد و به عصب و عروق فمورال نزدیک است، نه عصب سیاتیک. بنابراین، سیاتالژی از علائم این بیماری نیست.
- ☒ گزینه الف (غلط): کرورالژیا (Cruralgia) به دردی در مسیر عصب فمورال (جلوی ران) گفته می‌شود. از آنجایی که بورس ایلئوپسواس ملتهب می‌تواند به عصب فمورال فشار بیاورد، ایجاد دردی شبیه به درگیری این عصب (کرورالژیا) از علائم محتمل بیماری است.
- ☒ گزینه ج (غلط): بورس ایلئوپسواس ملتهب به دلیل نزدیکی به عروق فمورال (به ویژه ورید) می‌تواند باعث فشار و کاهش بازگشت وریدی شود که نتیجه آن تورم اندام تحتانی (Lower limb swelling) است.
- ☒ گزینه د (غلط): عضله ایلئوپسواس مسئول اصلی خم کردن مفصل ران (فلکسیون هیپ) است. بنابراین، درد در فلکسیون هیپ در برابر مقاومت یکی از علائم کلیدی و مشخصه بورسیت ایلئوپسواس است.

نکات کلیدی درسنامه: بورسیت ایلئوپسواس (Iliopsoas Bursitis)

- **آناتومی و مکانیزم:** بورس ایلیوپسواس، بزرگترین بورس بدن است که در **قسمت قدامی (جلوی) مفصل هیپ**، بین تاندون عضله ایلیوپسواس و کپسول مفصلی قرار دارد. التهاب آن اغلب به دلیل **ترومای تکراری** یا استفاده بیش از حد از عضله در ورزشکاران ایجاد می‌شود.

- **علائم بالینی:**

- **درد در کشاله ران (Groin pain).**
- **درد در هنگام فلکسیون (خم کردن) هیپ در برابر مقاومت.**
- ممکن است به صورت یک **توده در کشاله ران (Inguinal mass)** قابل لمس باشد.
- به دلیل فشار بر ساختارهای مجاور می‌تواند باعث **تورم اندام تحتانی** (فشار بر ورید فمورال) و **کروالژیا** (فشار بر عصب فمورال) شود.

- **تشخیص:**

- تشخیص بالینی است اما برای تأیید و رد سایر علل می‌توان از تصویربرداری استفاده کرد.
- **سونوگرافی و MRI** به خوبی تجمع مایع در بورس را نشان می‌دهند.

- **درمان:**

- استراحت و ورزش‌های کششی.
- **تزریق کورتیکواستروئید** که باید **تحت هدایت سونوگرافی** انجام شود تا از آسیب به عصب و عروق فمورال مجاور جلوگیری گردد.
- جراحی به ندرت مورد نیاز است.

سوال ۳ (ناحیه شانه)

صورت سوال: Speed test برای بررسی کدام مورد زیر بکار می‌رود؟

- الف) تاندینیت روتاتورکاف
- ب) تاندینیت بایسپس
- ج) اپی‌کندیلیت لترال
- د) Frozen shoulder

پاسخ تشریحی:

- **گزینه ب (صحیح):** تست Speed به طور اختصاصی برای ارزیابی **تاندون سر بلند عضله بایسپس** طراحی شده است. در این تست، بیمار دست خود را در حالی که آرنج صاف و ساعد به سمت بالا (سوپاین) است، در برابر مقاومت به جلو و بالا می‌برد (فلکسیون شانه). این حرکت مستقیماً به تاندون بایسپس فشار وارد کرده و در صورت وجود التهاب، باعث ایجاد درد در جلوی شانه می‌شود.
- **گزینه الف (غلط):** تست‌های اصلی برای تاندونیت روتاتورکاف شامل ایجاد درد در حرکات ابداکشن، چرخش داخلی یا خارجی در برابر مقاومت و وجود "قوس دردناک" است. تست Speed به طور مستقیم این تاندون‌ها را هدف قرار نمی‌دهد.

- ❌ **گزینه ج (غلط):** اپی‌کوندیلیت لترال (آرنج تنیس‌بازان) مربوط به آرنج است و با درد در **اکستنشن (باز کردن) مچ دست** در برابر مقاومت تشخیص داده می‌شود.
- ❌ **گزینه د (غلط):** Frozen Shoulder (کپسولیت چسبنده) با محدودیت کلی و شدید حرکات **فعال و غیرفعال** شانه در تمام جهات مشخص می‌شود و با یک تست تحریکی خاص تشخیص داده نمی‌شود.

نکات کلیدی درسنامه: تاندینیت بایسپس (Bicipital Tendinitis)

- **آناتومی و مکانیزم:** این بیماری التهاب **تاندون سر بلند عضله بایسپس** است که از داخل شیار در جلوی استخوان بازو (هومروس) عبور می‌کند. در ۹۵٪ موارد، این بیماری با مشکلات روتاتور کاف همراه است، زیرا بی‌ثباتی یا التهاب در آن ناحیه باعث اصطکاک و آسیب به تاندون بایسپس می‌شود.
- **علائم بالینی:**
 - **درد در قسمت جلوی شانه** که ممکن است به عضله بایسپس تیر بکشد اما به گردن انتشار ندارد.
 - درد با بلند کردن اجسام یا در طول شب تشدید می‌شود.
 - **حساسیت نقطه‌ای (Point Tenderness)** در لمس شیار بایسپس (۵-۷ سانتی‌متر پایین‌تر از آکرومیون).
- **تشخیص (مانورهای بالینی):**
 - **تست Speed:** فلکسیون شانه در برابر مقاومت، در حالی که آرنج صاف و ساعد سوپاین (رو به بالا) است. درد در جلوی شانه تست را مثبت می‌کند.
 - **تست Yergason:** سوپیناسیون (چرخش ساعد به بیرون) در برابر مقاومت، در حالی که آرنج ۹۰ درجه خم است. درد در ناحیه پروگزیمال و قدامی-داخلی بازو تست را مثبت می‌کند.
- **یافته‌های دیگر:** در صورت پارگی کامل تاندون، عضله به سمت پایین جمع شده و یک برآمدگی به نام **"تغییر شکل پاپای" (Popeye deformity)** ایجاد می‌کند.
- **درمان:**
 - استراحت و پرهیز از فعالیت‌های دردناک.
 - داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی (NSAIDs).
 - تزریق کورتون در فضای ساب‌آکرومیال.
 - در صورت پارگی حاد در فرد جوان و فعال، ترمیم جراحی توصیه می‌شود.

سوال ۴ (ناحیه شانه)

صورت سوال: کدام مورد از علل شایع کپسولیت چسبنده شانه **نمی باشد**؟

- الف) دیابت
- ب) تروما
- ج) بیماری قلبی ریوی

- (د) پارکینسون

پاسخ تشریحی:

- **گزینه د (صحیح):** در لیست بیماری‌های همراه با کپسولیت چسبنده که در درسنامه ارائه شده، **پارکینسون** به عنوان یک علت **نادر (rare)** ذکر شده است. در حالی که سایر گزینه‌ها به عنوان علل و عوامل خطر شایع‌تر مطرح شده‌اند.
- **گزینه الف (غلط):** **دیابت شیرین** یکی از مهم‌ترین و شایع‌ترین عوامل خطر برای کپسولیت چسبنده است. شیوع این بیماری در افراد دیابتی (۱۰-۲۰٪) بسیار بالاتر از جمعیت عمومی (۲-۵٪) است.
- **گزینه ب (غلط):** **تروما** و بی‌حرکتی طولانی مدت شانه پس از آن، یکی از علل شناخته شده برای این بیماری است.
- **گزینه ج (غلط):** **بیماری‌های قلبی-عروقی** (مانند سکته قلبی) و **بیماری‌های مزمن ریوی** نیز در لیست شرایط همراه با کپسولیت چسبنده در درسنامه ذکر شده‌اند.

نکات کلیدی درسنامه: کپسولیت چسبنده (Adhesive Capsulitis / Frozen Shoulder)

- **مکانیزم:** این بیماری با التهاب، ضخیم‌شدگی و فیبروز کپسول مفصلی شانه مشخص می‌شود. این "چسبندگی" باعث کاهش حجم مفصل و ایجاد درد و محدودیت شدید حرکت در تمام جهات می‌شود.
- **علل و عوامل خطر:**
 - **دیابت شیرین:** مهم‌ترین عامل خطر.
 - **بی‌حرکتی طولانی مدت:** پس از تروما، جراحی یا سکته قلبی (MI).
 - **اختلالات تیروئید، بیماری‌های قلبی-عروقی و بیماری‌های مزمن ریوی.**
 - پارکینسون (علت نادر).
- **اپیدمیولوژی:** بیشتر در خانم‌ها و در محدوده سنی ۵۰ تا ۷۰ سال دیده می‌شود و در افراد زیر ۴۰ سال نادر است.
- **علائم و تشخیص:**
 - درد منتشر در شانه و درد شبانه.
 - علامت کلیدی: **محدودیت حرکت هم فعال و هم غیرفعال** در تمام جهات. این محدودیت حتی با تزریق داروی بی‌حسی (مانند زایلوکائین) نیز برطرف نمی‌شود، که یک نکته تشخیصی مهم است.
 - تشخیص آن یک **تشخیص افتراقی (diagnosis of exclusion)** است و باید سایر علل مهم مانند آرتريت سپتیک، نکروز آواسکولار و نئوپلاسم‌ها رد شوند.
 - **آرتروگرافی:** در این روش، تزریق ماده حاجب به مفصل، کاهش شدید حجم کپسول مفصلی را نشان می‌دهد.
- **درمان:**
 - درمان اصلی و کلیدی، **فیزیوتراپی و انجام مداوم ورزش‌های کششی** برای بازیابی دامنه حرکتی است. این فرآیند ممکن است طولانی باشد.
 - استفاده از گرمای مرطوب، مسکن‌ها و داروهای NSAIDs برای کنترل درد.
 - **تزریق موضعی گلوکوکورتیکوئید** به کاهش التهاب و درد کمک می‌کند.

سوال ۶ (ناحیه مچ و دست)

صورت سوال: خانم ۳۲ ساله به علت درد شدید شست دست راست که مانع فعالیت بیمار میشود مراجعه کرده است. در معاینه محل کناره خارجی شست ملتهب و در کناره رادیوس متورم و دردناک هست. بیمار شیرخوار نه ماهه‌ای دارد و شیر میدهد. محتمل ترین تشخیص چیست؟

- الف) سندرم کانال کارپ
- ب) آرتروز شست دست
- ج) کیست گانگلیون
- د) تنوسینویت دکوئرون

پاسخ تشریحی:

- **گزینه د (صحیح):** این شرح حال، یک présentation کلاسیک برای **تنوسینویت دکوئرون (De Quervain's Tenosynovitis)** است. طبق درسنامه، این بیماری در **زنان باردار یا ۴ تا ۶ هفته پس از زایمان** بسیار شایع است. مکانیزم آن حرکات تکراری مچ و شست است که در مادران جوان به دلیل بلند کردن مکرر نوزاد رخ می‌دهد. درد و تورم در کناره خارجی مچ دست (روی زائده استیلوئید رادیوس) دقیقاً با این تشخیص مطابقت دارد.
- **گزینه الف (غلط):** سندرم کانال کارپ (تونل کارپال) باعث بی‌حسی، گزگز و درد در سه و نیم انگشت اول (شست، اشاره، میانی و نیمی از انگشت حلقه) می‌شود و درد آن معمولاً در ناحیه جلویی مچ متمرکز است، نه کناره خارجی.
- **گزینه ب (غلط):** آرتروز مفصل قاعده شست (مفصل کارپومتاکارپال اول) معمولاً در سنین بالاتر رخ می‌دهد و اگرچه می‌تواند باعث درد در این ناحیه شود، اما ارتباط قوی آن با دوره پس از زایمان و الگوی التهابی حاد، تشخیص دکوئرون را محتمل‌تر می‌کند.
- **گزینه ج (غلط):** کیست گانگلیون یک توده کیسه‌ای پر از مایع است که معمولاً دردناک نیست، مگر اینکه به ساختارهای مجاور فشار بیاورد. نمای بالینی در سوال بیشتر به یک فرایند التهابی اشاره دارد تا یک توده کیستیک.

نکات کلیدی درسنامه: تنوسینوویت دکوئرون (De Quervain's Tenosynovitis)

- **آناتومی و مکانیزم:** این بیماری، التهاب غلاف (سینوویوم) دو تاندون کنترل‌کننده حرکت شست است: **ابدکتور پولیسیس لونگوس (APL)** و **اکستانسور پولیسیس برویس (EPB)**. این تاندون‌ها از یک تونل تنگ در ناحیه زائده استیلوئید رادیوس (کناره خارجی مچ) عبور می‌کنند. حرکات تکراری مچ و شست، باعث اصطکاک، التهاب و ضخیم شدن غلاف تاندون‌ها شده و ایجاد درد می‌کند.
- **علل (اتیولوژی):**
 - حرکات تکراری مچ و شست: شایع‌ترین علت است.
 - بارداری و دوره پس از زایمان: به دلیل تغییرات هورمونی و بلند کردن مکرر نوزاد، در مادران ۴ تا ۶ هفته پس از زایمان بسیار شایع است.
 - ترومای مستقیم.
 - بیماری‌های التهابی.

- علائم بالینی:

- درد، تورم و حساسیت موضعی در ناحیه کناره خارجی مچ دست (که به آن Anatomical Snuffbox نیز می‌گویند).

- تشخیص (مانور بالینی):

- تست فینکل‌اشتاین (Finkelstein Test): این تست کلید تشخیص است. بیمار شست خود را در کف دست قرار داده و انگشتان دیگر را روی آن مشت می‌کند. سپس معاینه‌گر مچ دست را به سمت انگشت کوچک منحرف می‌کند (ulnar deviation). این حرکت باعث کشیده شدن تاندون‌های ملتهب و ایجاد درد شدید در ناحیه کناره خارجی مچ می‌شود که نشانه مثبت بودن تست است.

- درمان:

- استفاده از اسپلینت (آتل) برای بی‌حرکت کردن مچ و شست (Thumb Spica Splint).
- داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی (NSAIDs).
- تزریق موضعی کورتیکواستروئید در غلاف تاندون که معمولاً پاسخ درمانی بسیار خوبی دارد.

سوال ۷ (ناحیه شانه و آرنج)

صورت سوال: مانور بالینی Yergason برای کدام اختلال به کار می‌رود؟

- الف) آرنج تنیس بازان
- ب) آرنج گلف بازان
- ج) تاندینیت سر دراز عضله دو سر بازویی
- د) تاندینیت سوپرااسپیناتوس

پاسخ تشریحی:

- ☒ گزینه ج (صحیح): در این تست، بیمار در حالی که آرنجش ۹۰ درجه خم (flex) و در کنار بدن قرار دارد، سعی می‌کند ساعد خود را در برابر مقاومت معاینه‌گر به سمت خارج بچرخاند (supination). این مانور به طور اختصاصی تاندون سر بلند عضله بایسپس (دو سر بازویی) را تحت کشش قرار می‌دهد و ایجاد درد در جلوی شانه، نشانه مثبت بودن تست و وجود تاندینیت بایسپس است.
- ☒ گزینه الف (غلط): آرنج تنیس‌بازان (اپی‌کوندیلیت خارجی) با تست اکستنشن مچ دست در برابر مقاومت تشخیص داده می‌شود.
- ☒ گزینه ب (غلط): آرنج گلف‌بازان (اپی‌کوندیلیت داخلی) با تست فلکسیون مچ دست در برابر مقاومت تشخیص داده می‌شود.
- ☒ گزینه د (غلط): تاندینیت سوپرااسپیناتوس با درد در ابداکشن شانه در برابر مقاومت و وجود قوس دردناک (painful arc) مشخص می‌شود.

نکات کلیدی درسنامه: تاندینیت بایسپس و تشخیص افتراقی آن

(این بخش بر اساس درسنامه و گزینه‌های سوال برای درک بهتر تفاوت‌ها تنظیم شده است)

• تاندینیت بایسپس (Bicipital Tendinitis):

- آناتومی: التهاب تاندون **سر بلند عضله بایسپس**.
 - محل درد: جلوی شانه.
 - مانورهای تشخیصی:
1. **تست Yergason**: چرخش ساعد به خارج (سوپیناسیون) در برابر مقاومت، در حالی که آرنج ۹۰ درجه خم است.
 2. **تست Speed**: بالا بردن دست به جلو (فلکسیون شانه) در برابر مقاومت، در حالی که آرنج صاف است.

• تاندینیت سوپراسپیناتوس (بخشی از روتاتور کاف):

- آناتومی: التهاب تاندون **عضله سوپراسپیناتوس**.
- محل درد: بالای شانه.
- مانور تشخیصی: درد هنگام **دور کردن دست از بدن (ابداکشن)** در برابر مقاومت. وجود **قوس دردناک (Painful Arc)** بین زوایای ۶۰ تا ۱۲۰ درجه بسیار مشخصه است.

• آرنج تنیس‌بازان (اپی‌کوندیلیت خارجی):

- آناتومی: درگیری محل اتصال عضلات **اکستنسور (بازکننده) مچ دست** به اپی‌کوندیل خارجی آرنج.
- محل درد: قسمت خارجی آرنج.
- مانور تشخیصی: درد هنگام **باز کردن (اکستنشن) مچ دست** در برابر مقاومت.

• آرنج گلف‌بازان (اپی‌کوندیلیت داخلی):

- آناتومی: درگیری محل اتصال عضلات **فلکسور (خم‌کننده) مچ دست** به اپی‌کوندیل داخلی آرنج.
- محل درد: قسمت داخلی آرنج.
- مانور تشخیصی: درد هنگام **خم کردن (فلکسیون) مچ دست** در برابر مقاومت.

سوال ۸ (ناحیه مچ و کف پا)

صورت سوال: آقای ۱۸ ساله‌ای با درد شدید خلف پاشنه هر دو پا تحت بررسی هست. حساسیت در لمس خلف پاشنه‌ها و تورم اندک محل درد مشهود هست. درد بیمار صبح‌ها بیشتر هست و همزمان بیمار در ناحیه قدام قفسه صدری و لمس دنده‌ها نیز درد دارد. کدام عامل زمینه‌ای در این مشکل بیمار محتمل تر هست؟

- الف) استفاده از کفش نامناسب
- ب) دیابت
- ج) کم کاری تیروئید
- د) آرتریت سرونگاتیو

پاسخ تشریحی:

- **گزینه د (صحیح):** این بیمار علائم **انتزیت (Enthesitis)** را در دو محل متفاوت نشان می‌دهد: ۱) التهاب محل اتصال تاندون آشیل به پاشنه (درد خلف پاشنه) و ۲) التهاب محل اتصال لیگامان‌ها به دنده‌ها و جناغ (درد قدام قفسه صدری). طبق درسنامه، انتزیت یکی از تظاهرات اصلی **اسپوندیلوآرتروپاتی‌ها** است که گروهی از آرتریت‌های سرونگاتیو (Seronegative Arthritis) هستند. وجود انتزیت چند کانونی در یک مرد جوان، این تشخیص را بسیار محتمل می‌کند.
- **گزینه الف (غلط):** استفاده از کفش نامناسب می‌تواند باعث تاندینیت آشیل مکانیکی شود، اما درد همزمان در قفسه سینه را توجیه نمی‌کند.
- **گزینه ب و ج (غلط):** دیابت و کم‌کاری تیروئید اگرچه با برخی از مشکلات بافت نرم همراهی دارند، اما الگوی التهابی انتزیت چند کانونی در یک فرد جوان از مشخصات آن‌ها نیست.

نکات کلیدی درسنامه: تاندینیت آشیل (Achilles Tendinitis)

- **آناتومی و مکانیزم:** تاندون آشیل، بزرگترین تاندون بدن است که عضلات پشت ساق را به استخوان پاشنه متصل می‌کند. التهاب آن (که نوعی انتزیت است) می‌تواند ناشی از علل مکانیکی یا التهابی سیستمیک باشد.
- **علل (اتیولوژی):**
 - **مکانیکی:**
 - ترومای مستقیم.
 - فعالیت ورزشی بیش از حد (Athletic overactivity).
 - کفش نامناسب (Improperly fitting shoes).
 - **التهابی/سیستمیک:**
 - **اسپوندیلوآرتروپاتی‌ها:** شامل اسپوندیلیت انکیلوزان (AS)، آرتریت واکنشی (ReA) و آرتریت پسوریاتیک (PsA). این گروه از بیماری‌ها مشخصاً با انتزیت همراه هستند.
 - بیماری‌های کریستالی (مانند نقرس).
- **علائم بالینی:**
 - درد، تورم و حساسیت در لمس ناحیه پشت پاشنه.
 - درد با **دورسی‌فلکشن غیرفعال** (خم کردن پا به سمت بالا توسط معاینه‌گر) تشدید می‌شود.
 - ممکن است صدای کریپیتاسیون (Crepitation) در حرکت شنیده شود.
- **درمان:**
 - درمان اصلی شامل استراحت، یخ، و داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی (NSAIDs) است.
 - نکته بسیار مهم: تزریق کورتیکواستروئید در اطراف این تاندون به دلیل افزایش شدید خطر پارگی تاندون، اکیداً ممنوع است.

صورت سوال: خانم ۵۸ ساله خدمتکار با درد و تورم و قرمزی زانوی راست مراجعه کرده است. کدامیک مطرح نمی باشد؟

- الف) بورسیت پره پاتلار
- ب) آرتریت سپتیک
- ج) سلولیت ناحیه زانو
- د) نکروز آواسکولار

پاسخ تشریحی:

- ☒ **گزینه د (صحیح): نکروز آواسکولار (Avascular Necrosis)** یک بیماری داخل استخوانی است که در آن به دلیل قطع خون‌رسانی، بافت استخوان می‌میرد. این بیماری باعث درد داخل مفصلی می‌شود و علائم آن معمولاً به صورت تورم و قرمزی سطحی و موضعی مانند آنچه در سوال آمده، تظاهر نمی‌کند. بنابراین، کمترین احتمال را در تشخیص افتراقی این بیمار دارد.
- ☒ **گزینه الف (غلط): شغل بیمار (خدمتکار) که نیاز به زانو زدن مکرر دارد، او را به شدت مستعد بورسیت پره پاتلار (Prepatellar Bursitis) یا "زانوی خدمتکاران" می‌کند.** این بیماری با تورم، درد و گاهی قرمزی در جلوی زانو مشخص می‌شود.
- ☒ **گزینه ب (غلط): آرتریت سپتیک (عفونت مفصل)** یک اورژانس پزشکی است و با درد، تورم، قرمزی و محدودیت شدید حرکت مفصل تظاهر می‌کند. با توجه به علائم بیمار، این تشخیص حتماً باید در نظر گرفته شود.
- ☒ **گزینه ج (غلط): سلولیت (عفونت پوست و بافت زیرجلدی)** نیز می‌تواند باعث درد، تورم و قرمزی در ناحیه زانو شود و یکی از تشخیص‌های افتراقی مهم است.

نکات کلیدی درسنامه: بورسیت جلوی کشک (Prepatellar Bursitis)

- نام‌های دیگر: Housemaid's Knee (زانوی خدمتکاران).
- **آناطومی و مکانیزم:** این بیماری التهاب بورس سطحی است که بین پوست و استخوان کشک (پاتلا) قرار دارد. مکانیزم اصلی آن فشار یا ضربه‌های مکرر (میکروتروما) ناشی از **زانو زدن طولانی مدت** است. ضربه ناگهانی (ماکروتروما) نیز می‌تواند علت آن باشد.
- **علائم بالینی:**
 - **تورم موضعی و مشخص** در قسمت جلوی زانو، دقیقاً روی استخوان کشک.
 - درد و حساسیت نقطه‌ای در لمس.
 - درد معمولاً با خم کردن زانو (که پوست روی کشک را می‌کشد) تشدید می‌شود.
- **تشخیص افتراقی مهم:**
 - باید به احتمال **بورسیت سپتیک (عفونی)** توجه ویژه داشت، به خصوص اگر علائم التهابی شدید مانند **قرمزی (Erythema) و گرمی** وجود داشته باشد. عفونت در بورس‌های سطحی معمولاً از طریق آسیب موضعی به پوست وارد می‌شود. در صورت شک به عفونت، باید مایع بورس آسپیره و برای کشت و آنالیز فرستاده شود.

• **درمان:**

- پرهیز از زانو زدن و استفاده از پد محافظ زانو.
- داروهای NSAIDs.
- در موارد غیرعفونی و مقاوم، می‌توان مایع را آسپیره کرد و کورتیکواستروئید تزریق نمود.
- بورسیت عفونی نیازمند درمان با آنتی‌بیوتیک است.

سوال ۱۰ (ناحیه شانه)

صورت سوال: خانم ۴۲ ساله به دنبال تروما دچار صدمه در روتاتور کاف شده است. در حرکت مشاهده شده در تصویر (تصویر نشان‌دهنده چرخش داخلی بازو است) درد شدید و محدودیت حرکتی دارد. کدام تاندون درگیر است؟

- الف) ترس مینور
- ب) سوپراسپیناتوس
- ج) ساب اسکپولاریس
- د) اینفرا اسپیناتوس

پاسخ تشریحی:

- **گزینه ج (صحیح):** حرکت چرخش داخلی (Internal Rotation) بازو در برابر مقاومت، به طور اختصاصی عملکرد عضله و تاندون ساب‌اسکاپولاریس (Subscapularis) را ارزیابی می‌کند. این عضله در سطح قدامی (جلویی) استخوان کتف قرار دارد و مسئول اصلی چرخش بازو به سمت داخل است. بنابراین، درد و محدودیت در این حرکت نشان‌دهنده آسیب یا تاندینیت این تاندون است.
- **گزینه الف و د (غلط):** عضلات ترس مینور (Teres Minor) و اینفرا اسپیناتوس (Infraspinatus) مسئول حرکت چرخش خارجی (External Rotation) بازو هستند و با این مانور ارزیابی می‌شوند.
- **گزینه ب (غلط):** عضله سوپراسپیناتوس (Supraspinatus) مسئول شروع حرکت ابداکشن (بالا بردن دست از کنار) است و با این مانور تست می‌شود.

نکات کلیدی درسنامه: تاندینیت روتاتور کاف (Rotator Cuff Tendinitis)

- **آناتومی و عملکرد:** روتاتور کاف (کلاهی چرخاننده) از چهار عضله و تاندون‌های آن‌ها تشکیل شده که مفصل شانه را پایدار و حرکات آن را کنترل می‌کنند.
- 1. **سوپراسپیناتوس (Supraspinatus):** در بالای مفصل قرار دارد. **عملکرد اصلی:** شروع حرکت ابداکشن (Abduction) یا دور کردن بازو از بدن.
- 2. **اینفرا اسپیناتوس (Infraspinatus):** در پشت مفصل قرار دارد. **عملکرد اصلی:** چرخش خارجی (External Rotation) بازو.
- 3. **ترس مینور (Teres Minor):** در پشت و پایین مفصل قرار دارد. **عملکرد اصلی:** چرخش خارجی (External Rotation) بازو.

4. ساب اسکاپولاریس (Subscapularis): در جلوی مفصل قرار دارد. عملکرد اصلی: چرخش داخلی (Internal Rotation) بازو.

• **تشخیص بالینی بر اساس حرکت:** تشخیص تاندینیت هر یک از این عضلات بر اساس ایجاد درد هنگام انجام حرکت مخصوص آن عضله در برابر مقاومت پزشک است:

1. **درد در ابداکشن مقاومتی** ← به نفع تاندینیت سوپراسپیناتوس.
 2. **درد در چرخش خارجی مقاومتی** ← به نفع تاندینیت اینفراسپیناتوس و ترس مینور.
 3. **درد در چرخش داخلی مقاومتی** ← به نفع تاندینیت ساب اسکاپولاریس.
- **قوس دردناک (Painful Arc):** درد در میانه دامنه حرکتی ابداکشن (بین ۶۰ تا ۱۲۰ درجه) یک علامت کلاسیک برای سندرم گیرافتادگی (Impingement) و درگیری تاندون سوپراسپیناتوس است.
- **تمایز از آرتريت:** در تاندینیت، معمولاً حرکت فعال (Active) دردناک و محدود است اما حرکت غیرفعال (Passive) (که توسط معاینه گر انجام می شود) دامنه حرکتی نرمالی دارد. در آرتريت (التهاب مفصل)، هم حرکت فعال و هم غیرفعال محدود و دردناک است.

سوال ۱۱ (ناحیه شانه)

صورت سوال: فردی به دنبال زمین خوردن دچار درد شانه راست و محدودیت حرکتی شده هست. در معاینه قوس دردناک ۶۰-۱۲۰ درجه دارد ولی حرکات پاسیو نرمال هست. کدام تشخیص جهت بیمار مطرح می باشد؟

- الف) تاندونیت بایسپس
- ب) تاندونیت روتاتور کاف
- ج) آرتريت شانه
- د) تاندونیت کلسیفیک

پاسخ تشریحی:

- ☒ **گزینه ب (صحیح):** دو یافته کلیدی در این سوال وجود دارد که قویاً به نفع تاندینیت روتاتور کاف است:
 1. **قوس دردناک ۶۰-۱۲۰ درجه (Painful Arc):** این علامت، مشخصه کلاسیک سندرم گیرافتادگی تاندون سوپراسپیناتوس است که خود نوعی تاندینیت روتاتور کاف محسوب می شود.
 2. **حرکات پاسیو نرمال:** این یافته به ما کمک می کند تا آرتريت (التهاب مفصل) را رد کنیم. در تاندینیت، مشکل در واحد عضله-تاندون است، بنابراین حرکت فعال دردناک است، اما حرکت غیرفعال که توسط معاینه گر انجام می شود، دامنه طبیعی دارد.
- ☒ **گزینه الف (غلط):** تاندینیت بایسپس با تست های Speed و Yergason تشخیص داده می شود و محل درد آن در جلوی شانه است، نه لزوماً به صورت قوس دردناک.
- ☒ **گزینه ج (غلط):** در آرتريت شانه، هم حرکات فعال و هم حرکات غیرفعال (پاسیو) دردناک و محدود هستند. نرمال بودن حرکات پاسیو در این بیمار، آرتريت را رد می کند.

- **× گزینه د (غلط):** تاندینیت کلسیفیک نوعی تاندینیت روتاتور کاف است که با رسوب کلسیم مشخص می‌شود و می‌تواند باعث درد حاد شود، اما "تاندونیت روتاتور کاف" توصیف کلی‌تر و دقیق‌تری برای علائم بالینی ذکر شده (قوس دردناک) است.

نکات کلیدی درسنامه: اصول تشخیص دردهای شانه

- **تمایز کلیدی بین تاندینیت و آرتريت:**
 - **تاندینیت (و سایر اختلالات پری‌آرتیکولار):**
 - **حرکت فعال (Active Motion):** بیمار خودش دستش را حرکت می‌دهد. این حرکت **دردناک و محدود** است زیرا عضله و تاندون ملتهب در حال انقباض هستند.
 - **حرکت غیرفعال (Passive Motion):** معاینه‌گر دست بیمار را حرکت می‌دهد. این حرکت معمولاً **دامنه کاملی دارد و درد بسیار کمتری** ایجاد می‌کند، زیرا واحد عضله-تاندون در حالت استراحت است.
 - **آرتريت (التهاب خود مفصل):**
 - **هم حرکت فعال و هم حرکت غیرفعال** به یک اندازه **دردناک و محدود** هستند، زیرا مشکل در خود فضای مفصلی است و هرگونه حرکتی باعث درد می‌شود.
- **علامت قوس دردناک (Painful Arc Sign):**
 - **مکانیزم:** این علامت مشخصاً در **سندرم گیرافتادگی (Impingement Syndrome)** دیده می‌شود. هنگامی که بازو از کنار بدن بالا برده می‌شود (ابداکشن)، در دامنه میانی (حدوداً ۶۰ تا ۱۲۰ درجه)، فضای بین زائده آکرومیون و سر استخوان بازو به تنگ‌ترین حالت خود می‌رسد. در این محدوده، تاندون ملتهب سوپرااسپیناتوس و بورس ساب‌آکرومیال تحت فشار قرار گرفته و گیر می‌افتند که باعث ایجاد درد شدید می‌شود. در زوایای کمتر یا بیشتر از این محدوده، فضا بازتر است و درد کاهش می‌یابد.
 - **اهمیت:** وجود این علامت قویاً به نفع درگیری **تاندون سوپرااسپیناتوس** است.

سوال ۱۲ (ناحیه شانه)

صورت سوال: در بررسی بیمار با کپسولیت چسبنده کدام تست درخواست نمی‌شود؟

- الف) CBC
- ب) FBS
- ج) TSH
- د) PTH

پاسخ تشریحی:

- **گزینه د (صحیح):** در بخش "پاراکلینیک" در برنامه برای کپسولیت چسبنده، درخواست آزمایش‌ها برای بررسی بیماری‌های همراه ذکر شده است. این آزمایش‌ها شامل **FBS** (برای دیابت)، **CBC** (برای رد نئوپلاسم)، **ESR** و **TFT** (تست‌های عملکرد تیروئید که **TSH** بخشی از آن است) می‌باشد. هیچ اشاره‌ای به بررسی هورمون پاراتیروئید (**PTH**) و بیماری‌های مرتبط با آن به عنوان عامل خطر کپسولیت چسبنده نشده است.
- **گزینه الف، ب، ج (غلط):** همانطور که در بالا ذکر شد، **CBC** برای رد علل دیگر مانند بدخیمی‌ها، **FBS** برای بررسی دیابت (شایع‌ترین عامل خطر) و **TSH** برای بررسی اختلالات تیروئیدی، همگی جزو بررسی‌های منطقی و ذکر شده در برنامه برای بیمار مبتلا به کپسولیت چسبنده هستند.

نکات کلیدی در برنامه: بررسی پاراکلینیکی کپسولیت چسبنده

- **تشخیص:** تشخیص کپسولیت چسبنده (شانه یخ‌زده) عمدتاً **بالینی** و بر اساس شرح حال و معاینه (محدودیت حرکت فعال و غیرفعال در تمام جهات) است. این یک **تشخیص افتراقی (Diagnosis of exclusion)** است، به این معنی که باید سایر علل مهم درد و خشکی شانه رد شوند.
- **بررسی‌های آزمایشگاهی (پاراکلینیک):** هدف اصلی از انجام آزمایش، شناسایی بیماری‌های زمینه‌ای و همراه است که فرد را مستعد ابتلا به کپسولیت چسبنده می‌کنند.
 - **FBS (قند خون ناشتا):** برای بررسی **دیابت شیرین** که شایع‌ترین و مهم‌ترین عامل خطر است.
 - **TFT (تست‌های عملکرد تیروئید):** شامل **TSH**، برای بررسی **اختلالات تیروئیدی** (کم‌کاری یا پرکاری).
 - **CBC (شمارش کامل سلول‌های خون) و ESR:** به عنوان تست‌های غربالگری عمومی برای رد سایر بیماری‌ها مانند **عفونت (آرتریت سپتیک)** یا **نئوپلاسم‌ها (بدخیمی‌ها)** که می‌توانند علائم مشابهی ایجاد کنند.
- **بررسی‌های تصویربرداری:**
 - **رادیوگرافی ساده (X-ray):** معمولاً برای رد سایر علل مانند شکستگی، آرتروز شدید یا تومورهای استخوانی درخواست می‌شود و در کپسولیت چسبنده معمولاً نرمال است.
 - **آرتروگرافی (Arthrography):** در گذشته به عنوان تست تشخیصی استفاده می‌شد. تزریق ماده حاجب به مفصل، کاهش شدید حجم کپسول مفصلی را نشان می‌دهد که یافته‌ای تاییدی برای این بیماری است.

سوال ۱۳ (ناحیه مچ و دست)

صورت سوال: نام تست زیر چیست و در چه ضایعه‌ای مثبت می‌شود؟

- الف) تست فالن - درگیری عصب مدین
- ب) پرگاسون - تاندینیت بایسپس
- ج) تست فینکل اشتاین - تنوسینویت دکوترون
- د) اسپید - کپسولیت چسبنده

پاسخ تشریحی:

- **گزینه ج (صحیح):** تصویر نشان‌دهنده **تست فینکل‌اشتاین (Finkelstein Test)** است. در این مانور، بیمار شست خود را در کف دست مشت کرده و معاینه‌گر مچ را به سمت خارج (ulnar deviation) منحرف می‌کند. این حرکت باعث کشیدگی تاندون‌های ابدکتور پولیسیس لونگوس و اکستانسور پولیسیس برویس می‌شود. مثبت شدن این تست (ایجاد درد شدید) مشخصه **تنوسینوویت دکوئرون** است.
- **گزینه الف (غلط):** تست فالن شامل خم کردن کامل مچ‌ها به مدت یک دقیقه برای تشخیص سندرم تونل کارپال (درگیری عصب مدین) است و ظاهر متفاوتی دارد.
- **گزینه ب (غلط):** تست یرگاسون برای تشخیص تاندینیت بایسپس به کار می‌رود و شامل چرخش ساعد به خارج (سوپیناسیون) در برابر مقاومت است.
- **گزینه د (غلط):** تست اسپید نیز برای تاندینیت بایسپس است و کپسولیت چسبنده با تست‌های تحرکی تشخیص داده نمی‌شود.

نکات کلیدی درسنامه: تنوسینوویت دکوئرون (De Quervain's Tenosynovitis)

(این بخش برای تاکید و کامل بودن مجدداً آورده شده است)

- **آناتومی و مکانیزم:** التهاب غلاف تاندون‌های **ابدکتور پولیسیس لونگوس (APL)** و **اکستانسور پولیسیس برویس (EPB)** در حین عبور از اولین کمپارتمان اکستانسوری در کناره خارجی مچ دست.
- **علل:** حرکات تکراری مچ و شست، به ویژه در **مادران پس از زایمان** به دلیل بلند کردن نوزاد.
- **علائم بالینی:** درد، تورم و **حساسیت موضعی** در ناحیه زائده استیلوئید رادیوس.
- **تشخیص (مانور بالینی):**
 - **تست فینکل‌اشتاین (Finkelstein Test):** یک مانور تشخیصی بسیار مهم و حساس است. نحوه انجام:
 1. بیمار انگشت شست خود را در کف دست قرار می‌دهد.
 2. سایر انگشتان را روی شست مشت می‌کند.
 3. معاینه‌گر به آرامی مچ دست بیمار را به سمت انگشت کوچک (سمت اولنار) منحرف می‌کند.
 4. ایجاد درد شدید در مسیر تاندون‌ها در کناره خارجی مچ، تست را مثبت می‌کند.
- **درمان:** شامل **اسپلینت** برای بی‌حرکتی شست و مچ، داروهای **NSAIDs** و **تزریق موضعی کورتیکواستروئید** است که اغلب بسیار موثر است.

سوال ۱۴ (تعاریف پایه)

صورت سوال: کدامیک از جملات زیر تعریف درستی از انتزیت است؟

- الف) التهاب محل اتصال عضله به تاندون
- ب) التهاب استخوان مجاور عضله
- ج) التهاب محل اتصال تاندون یا لیگامان به استخوان
- د) التهاب عضله مجاور بورس

پاسخ تشریحی:

- **گزینه ج (صحیح):** این گزینه تعریف دقیق **انتزیت (Enthesitis)** است. بر اساس درسنامه، "انتز (Enthesis)" محل اتصال تاندون، لیگامان و یا کپسول مفصلی به استخوان است و التهاب این محل را انتزیت می‌نامند. این محل یک بافت تخصصی برای جذب استرس مکانیکی است.
- **گزینه الف (غلط):** محل اتصال عضله به تاندون را "اتصال میوتندینوس (myotendinous junction)" می‌نامند و التهاب آن جزو تعریف انتزیت نیست.
- **گزینه ب و د (غلط):** این گزینه‌ها به ترتیب به استئیت (التهاب استخوان) یا میوزیت (التهاب عضله) اشاره دارند که مفاهیم متفاوتی از انتزیت هستند.

نکات کلیدی درسنامه: انتز و انتزیت (Enthesis and Enthesitis)

- **تعریف انتز:** انتز یک ارگان یا واحد عملکردی تخصصی است که وظیفه آن متصل کردن **تاندون، لیگامان، یا کپسول مفصلی به استخوان** است. این ناحیه صرفاً یک نقطه اتصال ساده نیست، بلکه ساختاری پیچیده از جنس **فیبروکارتیلاژ (fibrocartilage)** دارد.
- **عملکرد انتز:** وظیفه اصلی انتز، انتقال نیروی تولید شده توسط عضله به استخوان و همچنین **جذب و توزیع استرس‌های مکانیکی** است تا از آسیب به نقطه اتصال جلوگیری کند.
- **تعریف انتزیت:** به **التهاب در محل انتز**، انتزیت گفته می‌شود. این التهاب یکی از ویژگی‌های بارز گروهی از بیماری‌های روماتیسمی به نام **اسپوندیلوآرتروپاتی‌ها** است (مانند اسپوندیلیت انکیلوزان، آرتریت پسوریاتیک و آرتریت واکنشی).
- **محل‌های شایع انتزیت:** بر اساس درسنامه، محل‌های مهمی که برای بررسی انتزیت باید معاینه شوند عبارتند از:
 - **پاشنه پا (محل اتصال تاندون آشیل و فاسیای پلانتر)**
 - **خارهای استخوانی ستون فقرات (Spinous processes)**
 - **قدام قفسه سینه (محل اتصال دنده‌ها به جناغ)**
- **اهمیت بالینی:** وجود انتزیت (مثلاً درد پاشنه یا درد قفسه سینه با الگوی التهابی) در یک بیمار با کمردرد یا آرتریت، یک سرخ تشخیصی بسیار مهم به نفع اسپوندیلوآرتروپاتی‌ها است.

سوال ۱۵ (مفاهیم پایه)

صورت سوال: کدام مورد بیانگر درگیری خارج مفصلی است؟

- الف) تاندینیت
- ب) تنوسینویت
- ج) بورسیت
- د) سینویت

(توجه: در این سوال به نظر می‌رسد خطایی در طراحی وجود داشته و منظور طراح "درگیری داخل مفصلی" بوده است. پاسخ زیر بر این اساس تحلیل شده است.)

پاسخ تشریحی:

- **گزینه د (صحیح با فرض اصلاح سوال): سینوویت (Synovitis)** به معنای التهاب غشای سینوویال است. این غشا لایه داخلی کپسول مفصلی است که مایع مفصلی را ترشح می‌کند و فضای داخل مفصل (Intra-articular) را می‌پوشاند. بنابراین، سینوویت مشخصاً یک فرآیند داخل مفصلی و مشخصه اصلی آرتريت‌های التهابی است.
- **گزینه الف، ب، ج (غلط با فرض اصلاح سوال): تاندینیت (التهاب تاندون)، تنوسینوویت (التهاب غلاف تاندون) و بورسیت (التهاب بورس)** همگی فرآیندهای التهابی هستند که در ساختارهای اطراف مفصل (Peri-articular) یا خارج مفصلی (Extra-articular) رخ می‌دهند. این موارد جزو دسته‌بندی روماتیسم بافت نرم هستند که در درسنامه توضیح داده شده‌اند.

نکات کلیدی درسنامه: دسته‌بندی درگیری‌های روماتیسمی

بیماری‌های روماتیسمی را می‌توان بر اساس محل اصلی درگیری به دو گروه بزرگ تقسیم کرد:

1. درگیری‌های مفصلی (Articular / Intra-articular):

- در این حالت، مشکل اصلی در ساختارهای داخل کپسول مفصلی قرار دارد.
- مشخصه اصلی آن آرتريت (Arthritis) است که با سینوویت (Synovitis) یا التهاب غشای سینوویال همراه است.
- **علائم بالینی:** معمولاً با تورم منتشر مفصل، گرمی و محدودیت دردناک هم در حرکت فعال و هم در حرکت غیرفعال مشخص می‌شود.
- **مثال‌ها:** آرتريت روماتوئید، لوپوس، نقرس.

2. درگیری‌های خارج مفصلی (Extra-articular) یا اطراف مفصلی (Peri-articular):

- در این حالت، ساختارهای اطراف مفصل مانند تاندون‌ها، لیگامان‌ها، بورس‌ها و عضلات درگیر هستند.
- **علائم بالینی:** درد معمولاً موضعی‌تر است و در یک نقطه خاص حساسیت وجود دارد (Point Tenderness). نکته کلیدی تشخیصی این است که معمولاً حرکت فعال دردناک است، اما حرکت غیرفعال دامنه نرمالی دارد یا درد بسیار کمتری ایجاد می‌کند.
- **مثال‌ها (بر اساس درسنامه):**

- **تاندینیت (Tendinitis):** التهاب تاندون (مثال: تاندینیت روتاتور کاف).
- **انتزیت (Enthesitis):** التهاب محل اتصال تاندون/لیگامان به استخوان (مثال: درد پاشنه در اسپوندیلیت انکیلوزان).
- **بورسیت (Bursitis):** التهاب بورس (مثال: بورسیت تروکانتریک یا پره‌پاتلار).
- **تنوسینوویت (Tenosynovitis):** التهاب غلاف تاندون (مثال: تنوسینوویت دکوئرون).

سوال ۱۶ (ناحیه زانو)

صورت سوال: خانم ۲۳ ساله با سابقه لوپوس تحت درمان با درد و تورم و قرمزی قدام زانوی چپ مراجعه کرده هست. تب ندارد. در معاینه حرکات اکتیو کاهش یافته ولی حرکات پاسیو نرمال هست. کدامیک از تشخیص‌های زیر جهت بیمار مطرح می‌باشد؟

- الف) عود لوپوس
- ب) بورسیت پره پاتلار
- ج) آرتريت عفونی
- د) آرتريت روماتوئید همزمان

پاسخ تشریحی:

- ☒ **گزینه ب (صحیح):** دو سرخ تشخیصی بسیار مهم در این سوال وجود دارد:
 1. **محل درگیری:** درد، تورم و قرمزی در **قدام زانو (Anterior knee)** که محل بورس پره‌پاتلار است.
 2. **الگوی حرکت:** کاهش حرکت فعال (اکتیو) همزمان با نرمال بودن حرکت غیرفعال (پاسیو). این الگو مشخصه اصلی یک مشکل پری‌آرتیکولار (اطراف مفصلی) مانند بورسیت است و یک مشکل آرتیکولار (داخل مفصلی) مانند آرتريت را رد می‌کند. بنابراین، با توجه به محل و الگوی درد، **بورسیت پره پاتلار (Prepatellar Bursitis)** محتمل‌ترین تشخیص است.
- ☒ **گزینه الف، ج، د (غلط):** عود لوپوس (که باعث آرتريت می‌شود)، آرتريت عفونی و آرتريت روماتوئید همگی باعث آرتريت یا التهاب داخل مفصل می‌شوند. در آرتريت، **هم حرکات فعال و هم غیر فعال** دردناک و محدود هستند. نرمال بودن حرکت پاسیو در این بیمار، این تشخیص‌ها را بسیار نامحتمل می‌کند.

نکات کلیدی درسنامه: بورسیت جلوی کشک (Prepatellar Bursitis)

- نام‌های دیگر: Housemaid's Knee (زانوی خدمتکاران).
- **آناتومی و مکانیزم:** این بیماری التهاب بورس سطحی است که بین پوست و استخوان کشک (پاتلا) در جلوی زانو قرار دارد. مکانیزم اصلی آن میکروترومای مکرر ناشی از فشار طولانی مدت بر روی زانو (مانند زانو زدن) یا یک ضربه مستقیم (ماکروتروما) است.
- **علائم بالینی:**
 - تورم، درد و حساسیت در قسمت جلوی زانو، دقیقاً روی استخوان کشک.
 - تورم معمولاً به صورت یک کیسه پر از مایع مشخص است.
 - ممکن است با قرمزی و گرمی پوست همراه باشد که در این صورت باید به فکر احتمال عفونت بود.
- **تشخیص افتراقی مهم:**
 - **آرتريت مفصل زانو:** در آرتريت، تورم معمولاً کل مفصل را در بر می‌گیرد (افیوژن مفصلی) و حرکات پاسیو نیز دردناک و محدود است.

- **بورسیت سپتیک (عفونی):** اگر علائم التهابی (قرمزی، گرمی شدید) وجود داشته باشد یا بیمار نقص ایمنی داشته باشد (مانند بیمار لوپوسی در سوال)، باید به عفونت شک کرد. عفونت در بورس‌های سطحی معمولاً از طریق آسیب موضعی به پوست رخ می‌دهد.

• درمان:

- پرهیز از فشار مستقیم بر زانو (استفاده از پد محافظ).
- داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی (NSAIDs).
- در موارد غیر عفونی و مقاوم، آسپیراسیون (تخلیه) مایع و تزریق کورتیکواستروئید.
- در صورت وجود عفونت، درمان با آنتی‌بیوتیک ضروری است.

سوال ۱۷ (ناحیه مچ و دست)

صورت سوال: کدامیک در باره تست فالن (Phalen) صحیح است؟

- الف) برای تشخیص درگیری عصب اولنار است.
- ب) مچ دستها را به مدت ۶۰ ثانیه در وضعیت اکستانسیون نگه می‌داریم.
- ج) اگر مچ دست درد گرفت تست مثبت است.
- د) مچ دست‌ها را به مدت ۶۰ ثانیه در حالت فلکشن نگه می‌داریم.

پاسخ تشریحی:

- ☒ **گزینه د (صحیح):** این گزینه به درستی روش انجام **تست فالن (Phalen Test)** را توصیف می‌کند. طبق درسنامه، برای انجام این تست، بیمار باید مفصل مچ را کاملاً به اندازه ۹۰ درجه **خم (فلکشن)** کند و به مدت **یک دقیقه** در این حالت نگه دارد.
- ☒ **گزینه الف (غلط):** تست فالن برای ارزیابی **عصب مدین (Median Nerve)** و تشخیص **سندرم تونل کارپال** به کار می‌رود، نه عصب اولنار.
- ☒ **گزینه ب (غلط):** تست فالن در حالت **فلکسیون (خم شدن)** کامل مچ انجام می‌شود، نه اکستانسیون (باز شدن). نگه داشتن مچ در حالت اکستانسیون به عنوان "تست فالن معکوس" شناخته می‌شود که کاربرد کمتری دارد.
- ☒ **گزینه ج (غلط):** معیار مثبت شدن تست فالن، ایجاد یا تشدید **گزگز، مورمور شدن یا بی‌حسی (پارستزی)** در انگشتان شست، اشاره، میانی و نیمه خارجی انگشت حلقه است، نه صرفاً درد در مچ دست.

نکات کلیدی درسنامه: سندرم تونل کارپال (CTS) و تست فالن

- **آناتومی و مکانیزم:** سندرم تونل کارپال ناشی از **فشار بر روی عصب مدین** در حین عبور از کانال تنگ تونل کارپال در مچ دست است.
- **علائم:** علائم کلاسیک شامل بی‌حسی، گزگز و درد شبانه در سه و نیم انگشت اول دست است که بیمار را از خواب بیدار می‌کند. تکان دادن دست‌ها معمولاً باعث بهبودی موقت می‌شود.
- **تست‌های تشخیصی بالینی:**

1. تست فالن (Phalen Test):

- **روش انجام:** از بیمار خواسته می‌شود مچ دست‌های خود را کاملاً خم کند (فلکسیون ۹۰ درجه) و پشت دست‌ها را به مدت ۶۰ ثانیه به هم بچسباند. این وضعیت باعث افزایش فشار داخل تونل کارپال می‌شود.
- **نتیجه مثبت:** بروز یا تشدید پارستزی (گزگز و بی‌حسی) در محدوده عصب‌دهی عصب مدین.
- **حساسیت و ویژگی:** طبق درسنامه، حساسیت (Sensitivity) این تست حدود ۶۸٪ و ویژگی (Specificity) آن ۷۳٪ است. این یعنی تست در همه بیماران مثبت نمی‌شود.

2. تست تینل (Tinel Test):

- **روش انجام:** ضربه زدن آرام با چکش رفلکس روی مسیر عصب مدین در جلوی مچ دست.
 - **نتیجه مثبت:** ایجاد حس برق‌گرفتگی یا گزگز در انگشتان.
 - **حساسیت و ویژگی:** حساسیت این تست (۵۰٪) از تست فالن کمتر، اما ویژگی آن (۷۷٪) کمی بیشتر است.
- **تشخیص قطعی:** تشخیص قطعی و ارزیابی شدت آسیب به عصب با **نوار عصب و عضله (EMG/NCV)** انجام می‌شود که معمولاً قبل از تصمیم به جراحی درخواست می‌گردد.

سوال ۱۸ (ناحیه شانه)

صورت سوال: پسر ۱۸ ساله با درد شدید قدام بازو بدنبال تروما مراجعه کرده است که بدنبال برداشتن اجسام و حمل آن‌ها تشدید میشود. فلکشن آرنج در برابر مقاومت باعث درد شدید می‌شود. تشخیص چیست؟

- الف) تاندینیت دکورون
- ب) هیچکدام
- ج) تاندینیت اینفرااسپیناتوس
- د) تاندینیت بایسپس

پاسخ تشریحی:

- ☒ **گزینه د (صحیح):** علائم بیمار قویاً به نفع **تاندینیت بایسپس** است. **درد در قدام بازو** که با **بلند کردن اجسام** تشدید می‌شود، از علائم ذکر شده در درسنامه برای این بیماری است. علاوه بر این، **درد در فلکسیون (خم کردن) آرنج در برابر مقاومت** مستقیماً عضله بایسپس (دوسر بازویی) را که یکی از عملکردهای اصلی آن خم کردن آرنج است، درگیر می‌کند و درد در این مانور، تشخیص را تأیید می‌کند.
- ☒ **گزینه الف (غلط):** تاندینیت دکورون باعث درد در **کناره خارجی مچ دست** می‌شود و ربطی به درد قدام بازو ندارد.
- ☒ **گزینه ج (غلط):** تاندینیت اینفرااسپیناتوس باعث درد در **پشت شانه** می‌شود و درد آن با **چرخش خارجی بازو** در برابر مقاومت تشدید می‌گردد.

نکات کلیدی درسنامه: تاندینیت بایسپس (Bicipital Tendinitis)

- **آناتومی و مکانیزم:** این بیماری التهاب **تاندون سر بلند عضله بایسپس** است. این عضله دو عملکرد اصلی دارد: (۱) کمک به بالا بردن دست به جلو (فلکسیون شانه) و (۲) خم کردن آرنج (فلکسیون آرنج). التهاب تاندون آن معمولاً به دلیل استفاده بیش از حد یا به صورت ثانویه به مشکلات روتاتور کاف ایجاد می‌شود.
- **علائم بالینی:**
 - درد در قسمت جلوی شانه و بازو.
 - درد با بلند کردن و حمل اجسام سنگین (lifting) یا فعالیت‌های بالای سر تشدید می‌شود.
 - درد شبانه نیز ممکن است وجود داشته باشد.
 - حساسیت نقطه‌ای در لمس شیار بایسپس در جلوی استخوان بازو.
- **تشخیص (مانورهای بالینی):**
 - **درد در فلکسیون آرنج در برابر مقاومت:** (همانطور که در سوال آمده) این مانور مستقیماً عضله بایسپس را درگیر می‌کند.
 - **تست Speed:** درد در فلکسیون شانه در برابر مقاومت (در حالی که آرنج صاف است).
 - **تست Yergason:** درد در سوپیناسیون **ساعد** (چرخش کف دست به بالا) در برابر مقاومت (در حالی که آرنج خم است).
- **درمان:** شامل استراحت، پرهیز از فعالیت‌های دردناک، داروهای NSAIDs و در صورت عدم پاسخ، تزریق کورتیکواستروئید در فضای ساب‌آکرومیال است.

سوال ۱۹ (ناحیه هیپ)

صورت سوال: خانمی چاق با پاراستزی و بی‌حسی ناحیه لترال ران راست مراجعه نموده است. کدام مورد مطرح است؟

- الف) بورسیت تروکانتر
- ب) مرالژیا پارستتیکا
- ج) آرتريت هیپ
- د) آرتريت عفونی هیپ

پاسخ تشریحی:

- ☒ **گزینه ب (صحیح):** مرالژیا پارستتیکا (Meralgia Paresthetica) یک سندرم ناشی از تحت فشار قرار گرفتن عصب پوستی خارجی ران (Lateral Femoral Cutaneous Nerve) است. این عصب صرفاً حسی بوده و مسئول حس ناحیه قدامی-خارجی (آنتروترال) ران است. علائم آن دقیقاً شامل بی‌حسی، گزگز و سوزش (پاراستزی) در این ناحیه است، بدون اینکه ضعف حرکتی وجود داشته باشد. چاقی یکی از ریسک‌فاکتورهای اصلی این بیماری است. در دیاگرام مربوط به علل درد هیپ در درسنامه نیز این بیماری و محل درگیری آن مشخص شده است.

- **× گزینه الف (غلط):** بورسیت تروکانتر باعث درد و حساسیت موضعی در ناحیه خارجی هیپ می‌شود، اما به طور معمول باعث بی‌حسی و پarestزی نمی‌شود.
- **× گزینه ج و د (غلط):** آتریت هیپ (چه عفونی و چه غیرعفونی) باعث درد عمقی مفصل (معمولاً در کشاله ران) و محدودیت حرکتی می‌شود، نه بی‌حسی و گزگز سطحی در پوست ران.

نکات کلیدی درسنامه: مرالژیا پarestتیکا (Meralgia Paresthetica)

- **مکانیزم:** این بیماری یک **نوروپاتی فشاری (Entrapment Neuropathy)** است که در آن **عصب پوستی خارجی ران** معمولاً در حین عبور از زیر لیگامان اینگوینال (کشاله ران) تحت فشار قرار می‌گیرد.
- **علت و عوامل خطر:**
 - چاقی (افزایش فشار شکمی).
 - پوشیدن لباس‌ها یا کمربندهای تنگ.
 - بارداری.
 - دیابت.
- **علائم بالینی:**
 - علائم **صرفاً حسی** هستند و ضعف عضلانی وجود ندارد.
 - شامل بی‌حسی، سوزش، گزگز، درد یا کاهش حس در ناحیه **قدامی-خارجی ران**.
 - علائم معمولاً با ایستادن یا راه رفتن طولانی تشدید شده و با نشستن بهبود می‌یابد.
- **تشخیص:** تشخیص عمدتاً **بالینی** و بر اساس شرح حال و معاینه دقیق حسی است. هدف اصلی، رد کردن سایر علل مانند مشکلات ریشه عصبی کمر (رادیکولوپاتی) است.
- **درمان:**
 - درمان معمولاً حمایتی است و شامل کاهش وزن، پوشیدن لباس‌های گشاد و پرهیز از وضعیت‌های تشدیدکننده است.
 - در موارد مقاوم، از داروهای کنترل درد عصبی یا تزریق موضعی کورتیکواستروئید استفاده می‌شود.

سوال ۲۰ (ناحیه هیپ)

صورت سوال: خانم ۵۲ ساله‌ای به دنبال سر خوردن روی برف و افتادن به پهلو دچار درد شدید کناره خارجی ران شده است. در معاینه درد بیمار در کناره خارجی ران با لمس تشدید می‌شود و تا زانو تیر میکشد. حرکات هیپ نرمال هست. تشخیص چیست؟

- الف) بورسیت ایلئوپسواس
- ب) بورسیت ایسکیال
- ج) بورسیت تروکانتر
- د) بورسیت انسرين

پاسخ تشریحی:

- **گزینه ج (صحیح):** شرح حال بیمار شامل دو نکته کلیدی است که قویاً به نفع **بورسیت تروکانتریک** است: (۱) **سابقه تروما (افتادن به پهلو)** که طبق درسنامه شایع‌ترین علت این بیماری است و (۲) **درد و حساسیت در کناره خارجی ران (روی تروکانتر بزرگ)**. نرمال بودن حرکات خود مفصل هیپ نیز تشخیص یک مشکل پری‌آرتیکولار (اطراف مفصلی) مانند بورسیت را بر یک مشکل آرتیکولار (داخل مفصلی) ترجیح می‌دهد.
- **گزینه الف (غلط):** بورسیت ایلئوپسواس باعث درد در **کشاله ران (قدام هیپ)** می‌شود.
- **گزینه ب (غلط):** بورسیت ایسکیال (Weaver's Bottom) باعث درد در **پایین باسن** می‌شود که با نشستن تشدید می‌گردد.
- **گزینه د (غلط):** بورسیت آنسرین باعث درد در **قسمت داخلی زانو** می‌شود.

نکات کلیدی درسنامه: بورسیت تروکانتریک (Trochanteric Bursitis)

- **آناتومی و مکانیزم:** التهاب کیسه مایع (بورس) واقع در قسمت خارجی لگن، روی برجستگی استخوانی **تروکانتر بزرگ**. این التهاب معمولاً به دلیل اصطکاک مکرر یا ضربه مستقیم ایجاد می‌شود.
- **علل (اتیولوژی):**
 - **تروما:** زمین خوردن یا ضربه مستقیم به ناحیه خارجی لگن **شایع‌ترین علت** است.
 - عوامل بیومکانیکی: چاقی، استئوآرتریت هیپ یا کمر، اختلاف طول پاها.
- **علائم بالینی:**
 - **درد و حساسیت نقطه‌ای در ناحیه لترال (خارجی) هیپ.**
 - درد با فعالیت‌هایی مانند بالا رفتن از پله، پیاده شدن از ماشین و **خوابیدن روی سمت مبتلا** تشدید می‌شود.
 - درد ممکن است به سمت خارج ران تیر بکشد (درد شبه رادیکولار).
- **تشخیص:** تشخیص بالینی است و با **مثبت شدن تست ابداکشن مقاومتی** (درد هنگام بالا بردن پا به سمت خارج در برابر مقاومت) تأیید می‌شود.
- **درمان:** درمان اصلی **تزریق موضعی کورتیکواستروئید** است که معمولاً بسیار مؤثر است. استراحت، استفاده از بالش بین زانوها هنگام خواب و ورزش‌های کششی نیز توصیه می‌شود.